

12 - 12- Le Prurit - Pr. Hocar

(0:00 - 10:30)

Chers étudiants, bonjour. J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui le cours intitulé le PROMIT. Le PROMIT est un signe fonctionnel très fréquent en dermatologie, soit comme étant le seul signe fonctionnel permettant aux patients à consulter, soit en étant associé à une dermatologie sous-jacente.

L'intérêt de cette question de ce cours réside dans le fait que c'est un signe très fréquent et qu'il faut savoir gérer un patient présentant un PROMIT par une technique bien structurée et systématique devant un PROMIT chronique ou même devant un PROMIT élevé. Chez un patient se plaignant d'un PROMIT, il faut savoir reconnaître la démarche diagnostic, reconnaître les principales idéologies de PROMIT avec le son lésion d'une dermatologie et bien sûr il faut savoir argumenter l'attitude thérapeutique et planifier le suivi du patient. Le PROMIT est un signe fonctionnel qui se définit comme une sensation qui provoque le besoin de se gratter.

Il peut être localisé ou généralisé. Il ne concerne que la peau et certaines muqueuses ou semi-muqueuses. Il existe un PROMIT qu'on peut qualifier de physiologique.

Ce PROMIT est discret, il est plus important le soir et au moment où le malade se déveine. Chaque individu se gratte de nombreuses fois dans une journée sans que cela entraîne un désagrément majeur. Le PROMIT devient pathologique lorsqu'il induit des lésions de grattage ou lorsqu'il incite à consulter.

Sur le plan physiopathologique, la physiopathologie du PROMIT est complète. Les stamines y sont souvent impliquées mais pas toujours. Le PROMIT peut parfois être plus haut dans les voies de transmission, c'est-à-dire le système nerveux central ou périphérique.

En général, son origine est bien en forme de cutanée. Il existe un contrôle de la porte, ce qu'on appelle un GATE, qui contrôle à tous les niveaux. Avant de passer à la démarche diagnostique, il faut savoir poser d'abord le diagnostic positif.

Généralement, le diagnostic positif d'un PROMIT clinique repose sur l'interrogatoire. Il peut être conforté par l'existence de lésions cutanément spécifiques consécutives au grattage, comme des exfoliations et des strides linéaires, voire des ulcérations. On peut avoir aussi des lésions de prédigout, ce formant de papulodésicule, papules excoriées aux croûteuses ou des modules humains.

On peut avoir de la liquidification, ça veut dire une peau épaisse, grisâtre, recouverte de fins coins, dessinant un quadrillage. Et puis, on peut aussi trouver des signes de surinfection comme l'imputivon ou l'épidermie. Le diagnostic différentiel, généralement, ce sont les sensations cutanées, à différencier, ce sont les dyshysthies, les paresthies et la douleur, ce sont vraiment

évident à différencier du COVID.

On arrive à la démarche diagnostic-étiologique et donc chercher une étiologie du COVID. On va être amené à un interrogatoire qui va préciser l'ancienneté, le mode de début, les facteurs déclenchants du COVID, l'horaire, l'intensité, le retentissement sur le vécu du patient, l'évolution et le traitement déjà pris par le patient, la notion de COVID dans l'entourage, la notion de prise médicamenteuse précise à l'apparition du COVID. Et bien sûr, il faut noter les antécédents médicaux et le mode de vie du patient, qui seront des éléments importants pour aboutir à une conduite étiologique.

On est toujours dans la démarche diagnostic-étiologique et on arrive à l'étape de l'examen clinique, donc un examen physique complet qui cherche en particulier des lésions cutanées, non expliquées par le grattage, mais permettant d'orienter vers une dermatose spécifique responsable du COVID. Elle cherche le thermographisme, chose qu'on a vu dans le cours du verticaire, cherche des anéropathies périphériques parfois, une hépatomégalie ou une splénomégalie, et bien sûr un examen général aussi à la recherche d'obtentions de la thérapie ou d'autres moyens qui pourraient expliquer l'apparition d'un COVID d'origine interne. Au terme de cet interrogatoire et examen clinique, on peut distinguer l'étiologie d'un COVID selon la topographie du COVID, donc si un COVID soit localisé sur un endroit donné qui va nous orienter vers une cause particulière, notamment un COVID anal, un COVID génital, un COVID du scalp, ou si on a des lésions dermatologiques spécifiques, ce qui va nous faire mener à pratiquer une biopsie cutanée, et donc on a une orientation étiologique précise de ce COVID.

Nous allons aux étiologies d'un COVID, nous allons voir en premier le COVID diffus associé à des lésions cutanées, notamment des macules, et quand on est devant des macules pigmentées, qu'on appelle aussi l'urticair pigmentaire, ce sont des lésions urticariennes et qui laissent place à des macules pigmentées séquellaires, caractéristiques de la masse tessutose ou de l'urticair pigmentaire. Et puis on a un fluoride diffus chronique associé à des papures, chose qu'on peut voir aussi dans les urticares chroniques au même ébut. On peut les voir au cours d'un léquinplan, c'est une dermatose inflammatoire caractérisée par l'infiltrat lymphocytaire de la jonction dermoépidermique et ça donne des lésions papuleuses très plurigéneuses.

Le léquinamide 8 aussi peut donner des lésions papuleuses très plurigéneuses, surtout au niveau de la région pré-tibiale. Et puis on arrive aux papulovésicules. Quand on est devant des lésions papulovésiculeuses très plurigéneuses, il faut penser un peu au strophoduce d'autant plus que ça surviendrait chez un enfant et la localisation surtout au niveau des extrémités, donc les mains, les avant-bras et les jambes et pieds, mais aussi on peut avoir un fluoride strophoduce avec des lésions de prurigo vésiculo-papuleuse sur les ondes de ceinture caractéristiques d'un prurigo strophoduce d'origine parasitaire.

Et puis on peut penser aussi à un prurigo gravitique d'autant plus qu'on a un pruride qui surviendrait chez une femme enceinte. À côté des dermatoses moiculopapuleuses

plurigéneuses, on peut voir aussi des dermatoses vésiculeuses comme l'eczéma de compact, comme la dermatite atopique, comme la varicelle, ou les dermatophétoses qui sont aussi des dermatoses vésiculeuses plurigéneuses. Et puis on peut avoir une dermatose auto-immune, une dermatose vileuse auto-immune, comme la pinfible ou la dermatite herpétique.

Donc le pruride est fréquent, souvent sévère et peut précéder les lésions cutanées qui sont selon ceux de urticariennes et vileses, comme la pinfible ou ce sont des lésions vésiculeuses ou vileses, dans le cadre d'une dermatite herpétique. Un pruride accompagné de lésions erréthémato-hispanoïdes, il faut penser aux lympho-cutanées, notamment de l'hypo-hispanoïde. Les lympho-cutanées généralement sont de type T, dites hypodermotropes, survenant le plus souvent chez le sujet âgé.

Il peut être révélé par des placards erréthémato-hispanoïdes plurigéneux. L'évolution des lésions se fait vers une infiltration de la peau avec des squames peu épaisses et un pruride important et insomniaux. Il y a aussi une entité qu'on appelle le syndrome de Césarée qui est une forme leucynique et erythrodermique des lympho-cutanées type T. Et puis on peut avoir aussi un pruride qui accompagne une érythrodermie dans le cadre d'une complication d'un eczéma ou d'un psoriasis ou d'un lympho-cutanée type T ou d'une toxidermie médicamenteuse.

Et puis on peut avoir aussi des lésions polymorphes, vesiculeuses, bulleuses, pleuriques et bulleuses et erythrodermiques dans le cadre d'une toxidermie médicamenteuse qui est souvent plurigénée. Un pruride chronique accompagner des lésions comme celles-ci que l'on voit sur la photo, ce sont des lésions erréthémato-squameuses, erréthémato-squameuses avec un aspect artiforme. Ce sont des lésions réparties surtout sur la partie des caissons, la partie de la région lombaire et la partie dorsale chez une patiente d'un certain âge, au-delà de 50 ans, il faut penser aux lympho-cutanées, tant que c'est une personne qui a un lympho-cutanée type T, appelé aussi myposis phangoïde, et souvent aussi une chose de plus en plus fréquente de prurides chroniques.

Une erythrodermie peut aussi s'accompagner d'un pruride, là c'est une personne qui avait un psoriasis et qui s'est compliquée d'une erythrodermie avec un épaissement cutané, un pruride très important. On peut avoir un pruride d'origine parasitaire comme dans le cadre d'une ectoparasitose, il faut savoir que la gale peut s'accompagner d'un pruride à reproduction nocturne, épargnant les visages avec topographie caractéristique et mise en évidence de science cabieux, voire beaucoup de la gale, et puis on peut avoir aussi des pédiculoses corporelles, des vagabonds, qui peut être la cause d'un pruride avec des lésions de grattage très importantes, même une mélanodermie. Il y a aussi la possibilité d'avoir des parasitoses tropicales en cause d'un pruride chronique, comme l'oncocercose, la vamigrance, les miasas et les lois.

Le pruride parasitaire peut s'accompagner de lésions non spécifiques, notamment de lésions de grattage, des lésions de prurigo-like ou du prurigo même, avec des lésions papuleuses, déséquileuses, des excoriations ou même des ulcérations. Donc c'est un patient qui présente un

pruride d'origine parasitaire. Là pour vous montrer aussi l'aspect des lésions chez le même patient, au niveau du pied, au niveau des extrémités, donc ce sont des lésions non spécifiques, papuleuses, érodées au centre, suite au grattage et sont aussi caractérisées par leur polymorphisme non spécifique.

Nous arrivons maintenant aux prurides diffusant lésions cutanées spécifiques ou prurides cimatéria. À l'examen clinique, il n'existe que des lésions cutanées provoquées par le grattage, incluant éventuellement des lésions de prurigo. Donc généralement, les infections généralement causées sont plus rares que les prurides dermatologiques.

(10:30 - 13:02)

Lorsque le pruride est nu, ça veut dire sans lésions dermatologiques, itulogiques, il est nécessaire de rechercher une infection générale qui va être en cause. Si on n'arrive pas à la trouver à l'examen clinique, à l'interrogatoire, on est amené à demander des examens complémentaires d'orientation et bien sûr, on va les voir plus loin. Les causes qu'on peut reconnaître, d'abord la cholestase.

Si un pruride est souvent poussé dans les égyptaires, la cholestase entre-hypathique et extra-hypathique avec ou sans égyptaire, souvent un pruride intense et insomnieux dans l'égyptaire, obstructif par cancer des voies biliaires, mais aussi dans le cadre d'un cancer du compréhens. Le pruride est souvent révélateur dans les cirrhoses biliaires primitives. On peut avoir une insuffisance rénale chronique.

Le pruride est rarement révélateur, mais très fréquent chez les maladies hémodialisées. L'insuffisance rénale aiguë ne provoque pas de pruride. Les causes endocriniennes, notamment les hyperthyroïdies, surtout la maladie de vase d'eau, les hypothyroïdies dont le pruride est souvent dû à la sécheresse cutanée et à l'hyposudation, mais aussi le diabète, la goutte, l'hyperluricémie, ne sont pas des causes de prurides défues et souvent le diabète est la cause d'un pruride localisé, mais aussi à l'origine des paresthésies.

On peut avoir aussi un pruride gravidique chez une femme enceinte, donc il faut y penser comme une étiologie du pruride, fréquemment associée à la proucesse. Une autre étiologie, ce sont les causes hématologiques, notamment les lave-femmes de prurides nues et chroniques. Chez un adulte jeune doit faire évoquer une maladie de Tchkin, le pruride est fréquent, le pronostic défavorable est parallèle à l'évolution de la maladie.

Il y a aussi la polygluvulite de Wackers, le pruride après un contact de l'eau, surtout en bain chaud, et les causes plus rares, dans le cadre d'une leucinélamphomie chronique ou d'une anémiphérie prive, peuvent être vues en cas de carence martiale importante. Il y a les causes infectieuses, il faut y penser, les infections parasitaires internes avec migrations tissulaires et périogénophilie, comme les Zidacibus dans notre contexte, et bien sûr, et peut-être responsable de prurides voire d'urine sans fuga, c'est non spécifique, comme des papillaires tucaniennes et

des lésions hexymatiphores. Il y a aussi l'HIV et l'hépatite C à chercher, bien sûr, dans le cadre d'un bilan systématique devant un pruride chronique.

(13:03 - 14:01)

Il y a des facteurs d'environnement en cause d'un pruride chronique, comme les végétaux, les agents végétaux, la laine de verre, les produits pesticides, les anticyclins rincés, le pruride aquagénique, il survient immédiatement après contact avec l'eau, il y a la sèche-face de la peau, la xérose, et puis il y a les variations de la température, l'humidité, qui peuvent être en cause, et puis on peut avoir aussi des maladies neurologiques, souvent des lésions cérébrales ou médullaires qui peuvent donner un pruride. Il y a aussi le pruride cygne, les psychogènes, ce sont vraiment des diagnostics délimineuses. Si on amène un interrogatoire et un examen clinique et on ne trouve aucune idéologie qui explique ce pruride chronique, nous, on est amené à prescrire ce bilan minimal, souvent à prescrire devant un pruride généralisé sans dermatose associée et chronique.

(14:02 - 14:44)

Systématiquement, il faut demander une numération formée sanguine et des plaquettes à la recherche d'une polyglobuline, d'une farence martiale, aussi à chercher une hyperiosinophilie au cas d'une parasitose. La vitesse de sédimentation va être accélérée en cas d'un enfant cutané et va être très abaissée en cas de polyglobuline. On demande une électrophorese de protéines plasmatiques pour chercher une gammaphatie monoclonale qui va nous aider à s'orienter vers un problème hématologique.

Le dosage de la créatinine mis à la recherche d'une insuffisance rénale occulte. Le bilan hépatique complet à la recherche d'une cholestase. Et bien sûr, un bilan théraumédien pour guetter une dysthéroïdie, notamment une hyper- ou une hypothéroïdie.

(14:45 - 19:27)

Radiographie pulmonaire à la recherche d'abionopathie profonde, d'un cystide adicte pulmonaire. L'échographie abdominopulmienne à la recherche d'un cystide adicte hépatique, d'une disabionopathie profonde dans le cadre d'un enfant. Et bien sûr, en fonction de l'orientation clinique, une biopsie cutanée associée à une immunoclaïrissane directe, il faut la demander systématiquement devant un clinique, nu, chez une personne âgée de plus de 50 ans, d'autant plus si on a des bulles, à la recherche d'une forme qu'on appelle la pérphébule bulleuse pré-bulleuse, selon sa précède d'apparition des bulles, d'un délai de six mois au moyen.

Il faut compléter aussi par un examen parasitologique de selle, en cas de voyage en zone tropicale, ou une biosynophilie dans l'animération formule fournie. Et bien sûr, sérologie du virus HIV, souvent un contexte particulier, ou si on a un amigrissement, ou une lymphopénie à l'animération fournie, aussi c'est des éléments à prescrire à un patient qui a un prurite fourni. À

côté des prurites nues, sans lésions dermatologiques, nous allons maintenant raisonner en fonction de la répartition topographique d'un prurite, donc un prurite localisé au niveau du cœur chevelu.

Il faut bien sûr faire chercher systématiquement une pédiculose, bien sûr on peut aussi chercher des autres causes, notamment l'intolérance aux produits cosmétiques, aux produits capillaires, l'état pédiculaire sain, chercher la psoriasis d'une liquidification de la nuque avec un prurite, souvent important. Chez un enfant, penser à la teigne et penser à des états pétériasiques qui peuvent expliquer un prurite, ou des complications d'une coupe d'épulose, forme de folie pulvide, du stade. Un prurite localisé au niveau du visage, il faut penser à la dermisiburrix, une dermatose caractérisée par des lésions hérétémateuses et squameuses au niveau du système nasogénien et au niveau de la partie haute des auxiles.

Et ça peut s'accompagner de lésions de dermisiburrix du point de vue auditif, du point de vue auditif externe, mais aussi des cheveux caractérisés par des squames grasses qui englobent les cheveux. Un eczéma de contact au niveau du visage, donc ça trace souvent l'agent appliqué ou l'agent qui touche le visage. Aussi, les photodermatoses sont des lésions prurigineuses qui sont aussi réparties selon les endroits photo-exposés, donc prédominant au niveau des zones convexes du visage, le front, le nez, les joues et le menton.

L'acné peut s'accompagner d'un prurit localisé lorsqu'on applique des traitements desséchants, mais aussi quand les lésions sont infectées, ça peut démanger. La xérose du visage peut s'accompagner aussi d'un prurit localisé lorsqu'il s'agit d'une dermatite atopique ou même d'une xérose toute simple du visage. Un prurit localisé au niveau de la région anal.

Chez un enfant, il faut penser à l'oxyose et il faut penser aussi à une condydose, à des hémorroïdes ou des fissures anales. Il faut penser aussi, dans un contexte de diaréctonique, on peut avoir un prurit et des localisations de dermatoses, comme le pso-inversé avec une atteinte péré-anale caractéristique du pso-alétonique. Un prurit localisé à l'appareil génital féminin peut penser à un léquin sclérose ou une dermatose qui est caractérisée par des lésions infiltrées, hérétémateuses et endurées à l'évolution cicatricielle.

Elles peuvent être atrophiques ou hypertrophiques. On peut avoir aussi de la condydose génitale, ce sont des lésions cercinées, hérétémateuses, accompagnées de leucorrhées. Et penser aussi à l'eczéma de contact au niveau de l'appareil génital, chose qui est fréquente, donc c'est un eczéma, selon le but, détergent, ou dû à des serviettes ou un linge particulier.

Il faut aussi penser à la léquinification, donc un prurit chronique, donc il doit, sur l'appareil génital, donner des lésions de léquinification ou une localisation d'une dermatose au niveau de l'appareil génital, comme le psoriasis ou le pso-inversé. Pareillement, sur l'appareil génital masculin, il faut penser à l'éclat sclérose, à la condydose, à l'eczéma de contact ou à une léquinification totale, donc un prurit localisé au niveau de la région des organes génitaux externes chez l'homme. Là,

c'est une diapositive de la stratégie diagnostique étiologique d'un prurit chronique, donc soit qu'il est localisé en la région des organes génitaux externes, soit qu'il est localisé dans le prurit localisé.

(19:27 - 19:58)

Les lésions de léquinification, ce sont des lésions non spécifiques ou des lésions qui vont caractériser l'étiologie. Les lésions non spécifiques, ce sont des lésions de grattage, de la léquinification du pré-riquet, des lésions érythémateuses, linéaires, de la pigmentation, de la dépilation, des exfoliations ou carrément de l'impetigisation. Quand le prurit est localisé, on va raisonner selon la topographie, est-ce que c'est un prurit du cuir chevelu, génital, masculin, féminin ou anal.

(19:59 - 20:57)

Quand c'est généralisé, avec les ondes herpétologiques caractéristiques, donc souvent l'agale ou l'épiderme, si on a des sciences cutanées, ou si on a des imminences parasitaires, ou on a des lésions du cou ou des arthropodes, carrément on les voit à la nuit ou au microscope. Si on a des lésions papuleuses et non des lésions vésiculeuses, huileuses ou érythrodermiques, des fois on est amené à raisonner sans qu'il y ait de lésions dermatologiques caractéristiques, donc toujours on est immunisé à l'agale, d'autant plus s'il y a un prurit familial. Et si on n'a pas d'étiologie évoquée au terme de l'examen clinique et l'interrogatoire, on prescrit un bilan standard, systématique, minimal, donc vous voyez les éléments, l'hémogramme, l'électrolyse des protéines, et les bilans hépatiques, hépatite PC, fonction rénale, bilan thyroïdien, radiothorax, échographie abdominale.

(20:57 - 21:52)

Et les autres causes de prurit, souvent c'est la peau sèche, psychogène, simple, il faut bien sûr éliminer toutes les possibilités étiologiques plus graves avant de retenir qu'il s'agit juste d'un prurit psychogène ou simple. Les étiologies sont surtout endocriniennes, métaboliques, cholestase, hémopathie, carence martiale, eau infectieuse, mais aussi médicamenteuse, donc bien sûr, au terme de ces investigations, on devrait avoir une étiologie sous le coude pour pouvoir gérer la prise en charge de ces patients. Comme je vous ai dit, le traitement est avant tout étiologique, mais on est amené à prescrire un traitement symptomatique qui va faire appel aux antihistaminiques, donc qui ont un rôle vraiment symptomatique, ils vont soulager le prurit du patient et vont lui permettre d'avoir une meilleure qualité de vie.

(21:53 - 22:37)

Et bien sûr, autant que possible, prévoyez un traitement étiologique, donc traitez la dermatose spécifique révélée par le prurit et traitez la cause interne, par exemple, le traitement de la polyglobulie, de la maladie de Schöber, va faire diminuer ou apparemment faire disparaître le

plurite. Il faut contrôler les facteurs déclenchants, arrêter les médicaments fortement suspects d'induire un plurite, bien sûr en accord avec le médecin prescripteur. Les conseils hygiénodétiques, limiter les facteurs irritants comme les antiseptiques alcooliques qui peuvent aussi induire des eczémas de contact ou des dermites irritatives, les dermocorticoïdes, les savons parfumés au acide, le contact avec la laine, ne pas porter des vêtements trop serrés pour réduire les lésions de grattage.

(22:38 - 23:02)

Et bien sûr, instaurer, comme je vous ai dit, un traitement symptomatique, maintenir une bonne hygrométrie ambiante. Les dermocorticoïdes seront utiles pour les lésions provoquées par le grattage mais ne sont pas recommandées en cas de plurite isolée. Les émollients, souvent les cérates ou les colprimes, les savons sur bras et les scindés seront les plus efficaces pour traiter l'axérose cutanée.

(23:02 - 23:24)

Et donc, bien sûr, quand on est devant un produit psychogène, il faut prescrire des psychotropes pour améliorer la qualité de vie de ses patients. Les éléments à retenir, c'est que le plurite est ainsi une fonctionnelle cutanée responsable de grattage. Les lésions élémentaires dermatologiques permettent en général le diagnostic d'une infection dermatologique qui est la cause du plurite.

(23:24 - 23:43)

En l'absence de lésions élémentaires, la recherche d'une cause de plurite repose sur un examen clinique et des hostiles et quelques examens complémentaires systématiques. Il n'y a pas de traitement général symptomatique du plurite. Les antihistamines ne sont antiplurigineux que si le plurite est médié par l'histamine comme dans l'URTIC.

(23:44 - 23:46)

Je vous remercie pour votre attention.